

Información Paciente

Nombre : Juan Pablo Zúñiga Carter

Edad : 48a 1m 19d

Dirección : -Los Corregidores 0788, San Geronimo

Rut : 12.574.958-5

Fecha Nacto: 30/01/1974

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1427192

Sexo : Masculino

Teléfono : 995008356

N° Epicrisis

297260

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 29/01/2022 04:10

Días Estadía: 49

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 19/03/2022 10:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Trauma lumbar

Comorbilidades

Hipertensión Arterial;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

Nombre: Juan Zúñiga Carter

RUT: 12574958-5

Edad: 48 años

FI CASR: 28/01/22

FI UTIM: 02/02/22

FI Sala: 21/02/22

ANTECEDENTES:

·Mórbidos: HTA, OH crónico, status convulsivo 2019 por sd de abstinencia.

·Quirúrgicos: (-)

·Fármacos: amlodipino 10 mg / día, Carvedilol 12.5 mg / día, Atorvastatina y fenitoína (Desconoce dosis)

·Alergias: (-)

·Hábitos: TBQ (+) IPA 15 aprox, OH crónico 1L día de cerveza, otras drogas (-)

·Hospitalizaciones:

2019 status convulsivo por privación de OH

2020 crisis convulsiva en estudio

·Inmunizaciones: (-)

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos consulta por historia de trauma, asociado a posterior dolor intenso en región lumbar e hipogástrica, con irradiación a testículos. Se realiza TC de abdomen y pelvis, en donde se describe fractura multisegmentaria del cuerpo vertebral de L1, con retropulsión del muro posterior. Se solicita evaluación por TMT, quienes describen retención urinaria aguda y paraplejía de tiempo no conocido, con fuerza EEII M1 proximal y M2 distal. Estando en el SU, presenta episodio convulsivo de menos de 1 minuto de duración, que yugular con 2 mg de lorazepam. Se estudia causa, con TC de encéfalo que no muestra lesiones agudas, HGT 159, y laboratorio general, pero el cuadro impresiona secundario a consumo reciente de OH + mala adherencia a terapia.

Se hospitaliza en plan de realizar cirugía descompresiva de columna, con diagnóstico de síndrome de cauda equina.

Fecha Epicrisis : 19/03/2022 10:44

Página 1 de 4

El paciente evoluciona con agitación severa, que requiere intubación para controlar (mala respuesta a terapia farmacológica + fractura lumbar). Ingres a pabellón 01/02 a laminectomía bilateral y descompresión amplia, distracción de la fractura, se fija y posteriormente se realizan maniobras de reducción, logrando reducción adecuada. Se deja drenaje. Cirugía sin incidentes. Sale a sala de recuperación, donde se intenta realizar Weaning pero paciente presenta 2 episodios tónico clónicos, que se interpretan como convulsión. Se decide diferir el Weaning y, evaluado por neurología, se decide carga de fenitoína con 1.2 g EV, y luego dosis de mantención de 200 mg. Cuenta con NP Fenitoína previos a la carga menor a 1.8. Se realiza EEG, sin evidencia de actividad epileptiforme o status. En ese contexto, se traslada a UPC para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

1-Síndrome de Cauda equina

a.Descompresión medular. -- Fijación T1-L2.

2-IOT 31/01

-Weaning diferido en contexto de convulsiones tónico clónicas

2.Antecedentes: HTA, OH, status convulsivo 2do a abstinencia por OH (2020), TEC en 2019 secundario a crisis convulsiva, TBQ

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS

1.Hemodinamia: Durante la hospitalización se mantiene sin requerimientos de DVA.

2.Ventilatorio: Paciente requirió VMI por agitación que no respondió a medidas farmacológicas habituales asociado a fractura lumbar, el 31/01. Se intenta Weaning, diferido por episodios convulsivos. Paciente se autoextuba el 03/02, sin requerir intubación de emergencia. Posteriormente con requerimientos de O2 a la baja, logrando destete de O2 el 22/02. KNT respiratoria.

3. Traumatológico: Paciente ingresó por cuadro compatible con síndrome de compresión medular por fractura traumática de L1, se realizó una laminectomía descompresiva y fijación T12-L2 el 01/02, con drenaje. El día 09/03 se auto retira el drenaje de forma accidental, es evaluado por traumatología a quienes impresiona herida en mejores condiciones, se retiran puntos el día 18/03, sin mayores incidentes y se define alta con control ambulatorio en CDT con traumatología en 3 semanas.

4. Infeccioso:

Neumonía aspirativa, tratada ampicilina/sulbactam x 6 días (TC tórax 01/02, CST flora comensal, HC negativos).

ITU CUP con orina inflamatoria y urocultivo polimicrobiano tratado empíricamente con amikacina por 5 días.

Durante hospitalización presenta episodio de diarrea aguda compatible con C. difficile (primer episodio, sin criterios de gravedad), por lo que se inicia Vancomicina oral (FI 11/02). Completa 14días, sin diarrea desde el día 21/02, posteriormente presenta nuevos episodios de diarrea, por lo que se decide iniciar nuevamente Vancomicina oral (FI 16/03) para completar 14 días y luego mantener 1 dosis al día de forma supresiva hasta completar terapia antibiótica.

Infección de herida operatoria en relación a laminectomía descompresiva: Presentó peak febril 07 y 09/02, se constató salida de material purulento desde herida operatoria, iniciando cobertura empírica con vancomicina. 17/02 Se realiza aseo quirúrgico, paciente en pabellón. Se mantiene Vancomicina EV, con muy buena respuesta. En cultivo 17/02 desarrollo de PSAE MS. Dada buena respuesta clínica a vancomicina, se decide mantener por 14 días y agregar ceftazidima. El día 02/03 fue evaluado por traumatología, quienes dada mejoría clínica y de laboratorio deciden mantener manejo con antibioterapia y drenaje. El día 09/03 se auto retira el drenaje de forma accidental, evaluado EL 11/03 por traumatología a quienes impresiona herida en mejores condiciones planteando eventual retiro de puntos. Luego de completados los 14 días de Vancomicina EV se mantuvo con ceftazidima posterior al retiro de puntos del día 18/03 se realiza cambio a ATB VO (ciprofloxacino) por al menos 6 semanas según lo discutido con equipo de infectología. Dado que paciente inicia nuevo episodio de diarrea con antecedente de CD reciente tratado, se solicita evaluación por infectología, Dra Donato refiere mantener vancomicina 125 mg cada 6 hrs oral - completar 14 días si mantiene buena evolución - luego mantener 125 mg al día mientras dure tto antibiótico

Control en 4 semanas por equipo para definir duración de terapia definitiva/ necesidad de control imagenológico.

5. Medio Interno: Sin conflicto al ingreso. Paciente evoluciona con tendencia a la hipomagnesemia, hipokalemia e hipofosfemia en contexto de síndrome de realimentación, actualmente corregida. Sin conflicto actual.

6. Psiquiátrico: En seguimiento por equipo de psiquiatría por manejo de abstinencia OH. CRequiriendo inicialmente manejo con benzodiazepinas, las cuales logra disminuir de forma progresiva hasta suspensión total. Se mantiene aporte de tiamina y ácido fólico. Al alta sugieren reforzar consulta en APS.

7. Neurológico: Antecedente de epilepsia, mantuvo crisis en ambulatorio en relación a consumo de OH y mala adherencia. Durante el periodo de weaning presentó 2 episodios sugerentes de crisis convulsivas, se cargó con fenitoína. EEG informó actividad lenta intermitente. NP FNT infraterapéuticos. Dado control errático de niveles de fenitoína se cambió a ácido valproico con lo cual no ha tenido episodios comiciales. Actualmente con ácido valproico, sin nuevos episodios convulsivos. Se indica control en 1 mes con neurología para definir terapia a futuro.

Fecha Última Actualización: 19-03-2022 10:44:12

Página 3 de 4

8. Nutricional: Paciente enflaquecido, en UCI se inicia alimentación por SNG, evoluciona con hipomagnesemia, hipokalemia e hipofosfemia en contexto de síndrome de realimentación que corrigen con cargas y suplementación de tiamina. En seguimiento por equipo logrando rehabilitación satisfactoria. Sin conflicto actual.

9. Rehabilitación: Evaluado por fonoaudiología, actualmente sin restricción de consistencias. En rehabilitación por KNT motora. En plan de continuar cuidados vía hospitalización domiciliar para continuar rehabilitación kinésica.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

1. Insuficiencia respiratoria aguda resuelta
2. Sepsis de foco articular +/- pulmonar resuelta
3. Diarrea x CD
 - a. Nuevo episodio de deposiciones diarreicas Vancomicina (FI 14/03)
 - b. Vancomicina (FI 11/02) 14/14
2. Obs neumonía asociada a atención en salud tratada
3. Infección de sitio quirúrgico - Laminectomía descompresiva con fijación T12 - L1/2 (01-02-22)
4. Trauma raquímedular complicado - Fractura L1 con ocupación de canal medular y compresión secundaria
5. Compromiso cualitativo de conciencia
 - a. Sd abstinencia OH - Consumo perjudicial de OH - episodios de abstinencia severos (2020)
 - b. Hipernatremia moderada sintomática resuelta
6. Epilepsia
 - a. Crisis reactivas post pabellón
 - b. Antecedente de crisis convulsiva por OH o mala adherencia
 - c. TEC no complicados
7. Anemia moderada normo normo (obs AEC)
8. Riesgo de desnutrición
9. Antecedentes: HTA

Diagnóstico de Egreso

Síndrome convulsivo -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Afebril, HDN estable, sin requerimientos de O2 suplementario. Deambulando con burrito. Deposiciones semiformadas.

Plan Post Alta

INDICACIONES

Reposo relativo asistido, deambular con andador.
Régimen hipercalórico hiperproteico, hiposódico asistido sentado 90°
Kinesioterapia motora diaria.
Curaciones de herida operatoria y LPP sacra día por medio.

Ácido Valproico ER 500 mg cada noche por VO a definir por neurología
Amlodipino 10 mg al día por VO a permanencia.
Ciprofloxacino 500 mg c/12 hrs VO a definir por infectología
Paracetamol 1 gramo SOS (máximo cada 8 hrs) en caso de dolor x VO
Vancomicina (indicación de infectología) mantener 125 mg cada 6 hrs oral - completar 14 días si mantiene buena evolución (hasta 29/03) - luego mantener 125 mg al día mientras dure tto antibiótico

CONTROLES

Control en Traumatología CDT en 3 semanas. Acudir a CDT con epicrisis para tramitar hora.
Control con Neurología CDT en 4 semanas. Evaluar terapia anticonvulsivante.
Control con Infectología CDT en 4 semanas. Evaluar duración de terapia ATB/ necesidad de imagen de control.
Mantener rehabilitación kinésica y curaciones vía hospitalización domiciliar x 30 días, luego mantener seguimiento por CESFAM de origen.
Control en APS con equipo de Salud Mental y equipo CV para evaluar Consumo perjudicial OH e HTA.

Fecha Epicrisis : 19/03/2022 10:44

Página 3 de 4

¿Acudir al Servicio de Urgencia en caso de fiebre, dificultad motora, diarrea pese al uso de terapia ATB o en caso que considera necesario¿.

Int. Uribe /Dr. Llaría/ Dr. Neumann

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

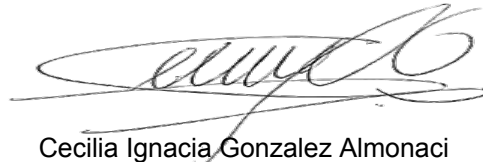
08/04/2022 - CDT - Traumatología - Control clínico, evaluar retiro de material protésico

15/04/2022 - CDT - Infectología - Definir duración terapia ATB, necesidad de imagen.

15/04/2022 - CDT - Neurología Adulto - Evaluar terapia para Epilepsia

Sofía Paz Villagrán Essmann

INTERNO



Cecilia Ignacia Gonzalez Almonaci

Becado/Residente

Sofía Paz Villagrán Essmann

Médico Tratante (Staff)